의료진 진료 카드 · ASL-088

RSV · 대상과 기접종 확인

2026 강의에 소개된 대한감염학회 권고. 연령과 중증 감염 위험요인을 함께 본다.

처음 접종인지 확인한 뒤 연령·위험도를 본다



50~74세 · 위험요인 ①

심혈관·호흡기	심부전·관상동맥질환·선천성 심장질환 등 만성 심혈관질환(단순 고혈압 제외). COPD·폐기종·천식·간질성 폐질환·낭포성 섬유증 등 만성 폐/호흡기질환.
신장·당뇨병	말기 신장질환 또는 혈액투석·기타 신대체요법 의존. 당뇨병은 만성 신질환·신경병증·망막병증 등 장기 손상 동반 또는 인슐린이나 SGLT2 억제제 치료가 필요한 경우.
신경·근육	기도 청소 장애 또는 호흡근 약화를 유발하는 신경/신경근육질환. 뇌졸중 후 연하곤란·ALS·근이영양증 등. 기도 청소 장애 없는 뇌졸중 병력은 제외.

50~74세 · 위험요인 ②와 접종시기

그 밖의 위험요인	만성 간질환(간경변), 만성 혈액질환(겸상적혈구병·지중해빈혈), 중증 비만 BMI ≥40 kg/m², 중등도·중증 면역저하, 요양시설(요양원) 거주.
시기·횟수	대상자는 연중 언제든 1회. 국내 RSV 유행은 약 10월 말~3월 말, 가능하면 8~10월 접종. 독감처럼 매년 반복접종하지 않는다.

연자 Q&A: Arexvy 1회 접종자에게 Abrysvo를 다시 권하지 않는다. 두 제품의 교차 추가접종은 권고되지 않으며 부작용 위험도 있다고 답변했다.

의료진 진료 카드 · ASL-088

RSV · 제품과 반복접종 설명

허가 범위와 접종 권고는 다르다. 아래 제품 정보는 강의 시점의 설명이다.

본강의 · 제품 구성과 국내 허가 설명

Arexvy	RSV-A preF 단백항원 120μg + AS01E 면역증강제. 강의 표의 국내 허가: ≥60세 성인, 50~59세 고위험군. 권고는 ≥75세 전체·50~74세 고위험군.
Abrysvo	RSV-A·B preF 항원 각각 60μg, 면역증강제 없음. 강의 당시 국내 허가를 2026년 하반기 예정으로 소개. 미국 임신 32~36주 접종을 신생아 항체 전달 전략으로 설명.
mRESVIA	RSV-A preF를 인코딩하는 mRNA-1345 50μg. 별도 면역증강제 없이 mRNA·지질나노입자 자체 효과로 설명.

본강의 · 예방효과와 재접종 연구

1시즌 효능	Arexvy: 하기도질환 82.6%, 중증 하기도질환 94.1%, 급성 호흡기감염 71.7%. Abrysvo: 하기도 85.7%(증상 ≥2개 66.7%), 급성 감염 62.1%. mRESVIA: 하기도 83.7%(증상 ≥2개 68.4%), 급성 감염 68.4%. 서로 다른 연구·평가변수의 수치.
연구 설계	Arexvy AReSVi-006: ≥60세 24,966명, 17개국 278기관. 첫 시즌 접종자를 다음 시즌 전 1:1로 재접종/1회 유지 배정; 2차 이득이 뚜렷하지 않아 3차 접종 중단 후 추적.
상담의 핵심	현재 1회 원칙이며 정기 추가접종은 권고되지 않는다는 강의 결론. 접종 유무·제품을 확인해 불필요한 반복을 막는다.

연자 Q&A · 비용 상담

≥75세

가격이 높더라도 질병 부담을 고려해 접종을 적극적으로 설명할 가치가 있다고 답변.

50~74세 고위험군

만성 심폐질환·면역저하 등 중증 위험이 높은 경우 접종을 설명. 모든 성인 일률 접종과 구분한다.

의료진 진료 카드 · ASL-088

RSV · 효과 지속과 안전성

접종 후 시간이 지나며 효과가 낮아져도 정기 재접종은 별개의 판단이다. 강의가 소개한 연구별 수치를 구분한다.

본강의 · 반복접종과 지속성

3시즌 비교	Arexvy 하기도질환 누적 효능: 1회 62.9%(97.5% CI 46.7~74.8), 재접종 69.8%(42.2~85.7). Placebo와 각각 간접 비교했고 신뢰구간이 겹쳐 유의 차이가 없다고 설명.
시즌별	Arexvy 1회군: 1시즌 82.6%, 2시즌 56.1%, 3시즌 48.0%; 재접종군 2시즌 55.9%·3시즌 68.4%. 1회 누적 2시즌 67.2%·3시즌 62.9%.
다른 백신	Abrysvo 2시즌 효능 77.8%(증상 ≥2개 55.7%), 누적 81.5%(60%). mRESVIA 83.7%(3.7개월)·62.5%(8.6개월)·56%(12개월), 12~24개월 30%, 24개월 누적 47.4%로 소개.
실제 진료 연구	VISION 입원 예방효과 80%(95% CI 71~85), 응급실 77%(70~83). VA ≥60세 2시즌 연구 12개월 감염·응급실·입원 예방은 70%대, ICU 약 80%. 다음 시즌부터 감소하는 추세를 설명.

본강의 · Guillain–Barré 증후군

안전성 신호	Abrysvo 시험에서 GBS 1건·Miller–Fisher 1건, Arexvy 두 번째 시험에서 GBS 1건을 소개.
100만 접종당 추가 위험	강의 표: Arexvy 5.2(−0.9~9.2), Abrysvo 18.2(9.8~23.3). 독감백신은 1~2로 비교. 절대 빈도는 낮지만 모니터링할 이슈라고 설명.
이득·위험 추정	다른 강의 표(MMWR, ≥60세 미국 2시즌 추정)는 GSK GBS 3(0~10), Pfizer 16(5~28)/100만 접종. 연자는 100만 명 접종으로 RSV 사망 약 1,000명 예방과 GBS 3~16명 가능성을 함께 설명.

접종 횟수는 현재 권고인 1회를 따른다는 강의 결론을 유지한다. 장기 효과 감소·재접종 연구 결과만으로 다른 제품이나 매년 추가접종을 권하는 카드로 바꾸지 않는다.